

Paciente: PAULO AUGUSTO SILOTTO DIAS DE SOUZA

Ident.: 5463652

Médico: MARCO ANTONIO DE CARVALHO - CRM-99607

Data Nasc: 14/07/1961

Data: 15/05/2026

Sexo: M

Idade: 64 A 10 M

Convenio: BRADESCO SAUDE

Usuário: 5463652

Senha: 19004



Faça a leitura do QR code
para visualização das
imagens deste laudo

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR

Técnica: Estudo realizado com multiplanar em sequências ponderadas em T1, T2 e STIR, sem a administração de contraste endovenoso paramagnético.

Descrição:

Desvio sinistro-convexo do eixo na posição do estudo. Retificação da curvatura lombar fisiológica. Anterolistese discreta de L3 sob L4. Mínima retrolistese de L1 sobre L2

Corpos vertebrais com altura normal e osteófitos marginais.

Hipohidratação e redução difusa das alturas discais.

Discopatia degenerativa de L1-L2, L2-L3 e L4-L5 com irregularidade dos platôs apostos e alteração de sinal do tipo Modic I (edema) nos três níveis e Modic II (gordura) em L4-L5.

Abaulamento discal discreto de L1-L2 que retifica a face ventral do saco dural e reduz as amplitudes foraminais bilaterais, notadamente à esquerda.

Abaulamento discal difuso de L2-L3 que comprime a face ventral do saco dural, toca as descendentes anteriores e reduz as amplitudes foraminais bilaterais com estenose e compressão da emergente à esquerda.

Pseudoabaulamento discal difuso de L3-L4 que comprime a face ventral do saco dural e associada a hipertrofia das interfacetárias e espessamento dos ligamentos amarelos, determina estenose do canal vertebral, com compressão das descendentes anteriores e redução das amplitudes foraminais bilaterais, notadamente à esquerda, tocando a respectiva emergente.

Abaulamento disco-osteofitário difuso de L4-L5 com componente discal protruso na região central, que comprime a face ventral do saco dural, tocando as descendentes anteriores bilaterais e reduz as amplitudes foraminais tocando a emergente direita.

Extrusão discal paramediana/foraminal esquerda de L5-S1 que, associada a hipertrofia da facetária ipsilateral, comprimem a respectiva descendente ipsilateral de S1.

Cone medular e cauda equina tópicos de morfologia e intensidade de sinal normais.

Moderada hipotrofia da musculatura paravertebral.

Edema do ligamento interespinhoso de L2-L3, L3-L4 e L5-S1.

Conclusão:

Desvio sinistro-convexo do eixo na posição do estudo. Retificação da curvatura lombar fisiológica. Anterolistese discreta de L3 sob L4. Mínima retrolistese de L1 sobre L2

Espondilodiscopatia degenerativa difusa e multisegmentar conforme pormenorizado acima.

Edema do ligamento interespinhoso de L2-L3, L3-L4 e L5-S1.

Moderada hipotrofia da musculatura paravertebral.



Dra. Juliane G. Hortolam

Médica Radiologista

CRM-SP 144689 / RQE 76161

Título AMB / CBR 302105